

ד"ר אילן תירוש - פסיכיאטר מומחה

מספר רישיון: 11-88888

סיכום אבחנתי והערכה קלינית

פגשתי את הפציינט בתאריך 03/05/2026

מעקב סטטוס תרופתי

- דיווח מטופל: המטופל נמצא כעת 3 שבועות תחת מינון מלא של ציפרלקס 10 מ"ג. מצביע על ירידה קלה במפלס החרדה הכללי, אך מתלונן על תופעת לוואי משמעותית של עייפות מסיבית, סדציה (נמנום) ו"טשטוש מוחי" קשה המתחילים כשעתיים לאחר נטילת התרופה בבוקר. מדווח כי המצב פוגע באופן קשה ביכולת הריכוז ובתפקוד בעבודה, ומחמיר את קשיי הזיכרון הקיימים ממילא. הפרעות השינה פחתו במעט, אך סיוטי הלילה נמשכים.
- סטטוס פסיכיאטרי: מתוח פחות בהשוואה לביקור הקודם, אך ניכרת לאות פיזית בולטת. אפקט תואם, יציב. ללא קווים פסיכוטיים או סיכון עצמי.
- התרשמות רפואית: תופעת הלוואי המרדימה של ה-SSRI פוגעת ברווחת המטופל בשעות היום. במקום החלפת תרופה בשלב מוקדם זה, נכון לנצל את האפקט הסדטיבי לטובת השינה בלילה ולמנוע את הטשטוש ביום על ידי שינוי שעת הנטילה.

המלצות:

1. שינוי משטר נטילה: החל ממחר, יש להעביר את נטילת כדור הציפרלקס (10 מ"ג) משעות הבוקר לשעות הערב. המטופל ייקח כדור אחד שלם מדי יום בשעה 20:00 בדיוק, כחצי שעה לאחר ארוחת הערב.
2. צמצום גירויים נוירולוגיים: הקפדה על כיבוי מוחלט של מסכים (טלפון, טלוויזיה, מחשב) החל מהשעה 21:30 (שעה לפני השינה) לשיפור איכות רצף השינה.